



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : زينب ابراهيم محمد الشماع

المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : بولاق الدكرور العنوان : كك

رقم البطاقة : 26807042100586 رقم التليفون : 01202284523 تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 04-07-1968 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام موجات صوتيه علي الثدي والابطين والرقبه

[4142]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / / د. / / د. / / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: زينب ابراهيم محمد الشماع National ID: 26807042100586	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Ultrasound of the breast, axillae and neck
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



رئيس
ابراهيم محمد الشماخ
قرية ابو النمرس
مركز ابو النمرس - الجيزة

١٩٦٨/٠٧/٠١ ٢٠١٨.٠٧.٠٤ ٢١.٠٥.٨٦

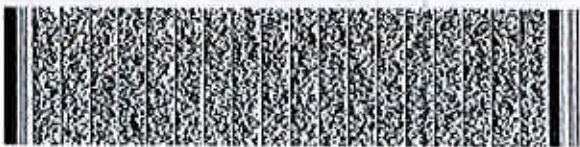
LH6556411

٢٠٢٥/٠٨ ٢٠١٨.٠٧.٠٤ ٢١.٠٥.٨٦

رية منزل
انثى
ربيع محمد عبدالوهاب زعلان

٢٠٢٢/٠٨/٠١ البطاقة سارية حتى





MDT FORM

6111/2025 G

<u>Name</u>	سید محمد	<u>MRN</u>	2581/25
		<u>ID</u>	C7N.V.2.C1...0
<u>Age</u>	57	<u>Phone</u>	01177156515
<u>Menopausal status</u>		<u>Marital status</u>	
<u>NRS SCORE</u>		<u>Family history</u>	Yes
<u>BMI</u>		<u>REASON OF MDT</u>	
<u>CO morbidity</u>	Free		

Clinical Data

BX: <u>IPG GII</u>				R	L
ER: <u>8/8</u>	PR: <u>5/8</u>	HER 2: <u>+1</u>	KI67: <u>40%</u>		
<u>Sonomammography:</u> RT W 100 Lbl asymmetrical area 6-7 o'clock (2 o'clock), 5mm from axillary skin 17x25					
<u>Mets Workup:</u> - few indeterminate axillary LN (level 1), pos. hila				IN, M ₀	
<u>Free</u>					

Recommendations:

وہابیہ

۱۰/۱۰/۱۰

MDT OUTCOME & PLAN

- Breast Clipping
- NACT (4 cycles AC $\rightarrow$ 12 wk Taxol)

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
7/2/2023	Dr. Hash	5/11/2023			

Name: زينب ابراهيم محمد الشماع		
MR. : 4167		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
NACT AC 4 TAXOL 12 WKS FOR WEEK 1 TAXOL W 2 AND 3 PHARMACY WT HT SA 1.9 TAXOL 150 mg (80mg/m2) clinical pharmacy note : for w3 taxol 150 mg for clinic visit nacth :w4 taxwol 150 (w5 and w6 and w7 in pharmacy) Pharmacy Visit For W7 Taxol 150 Labs 29/3 ... accepted w12 taxol 150mg add methyltechno + controloc +cetal. The patient is currently receiving the 12th week of TAXOL 150 mg as part of the NACT AC regimen, with additional agents methyltechno, controloc, and cetal added to the treatment plan.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر	
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

PATHOLOGY DEPARTMENT HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: زينب ابراهيم محمد الشماع	Age: 57years	Sex: female
Request type: مبانزه	Sub request type:	
Hospital no:	Pathology no.: 470B-2025	
Department: صحة مرآه	Date of result:	
Referred by: د/مروه حسن	Date of biopsy: 26/8/2025	
Nature of specimen: Tru-cut biopsy	I.D. Number: 26807042100586	
Clinical diagnosis: Right breast mass		

Gross pathology: Multiple grayish white tissue cores up to 1cm long, totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67.

Microscopic picture: Sections examined revealed breast tissue core showing invasive duct carcinoma (NST). Tumor forms sheets, clusters, cords and trabeculae infiltrating among desmoplastic stroma. Tumor cells showed moderate anaplasia with moderate tendency to form tubules and mitosis. There is no ductal carcinoma insitu seen.

Immunohistochemistry:

ER. Strong positive nuclear staining in 80% of tumor cells (8/8).

PR. Moderate positive nuclear staining of 30% of the tumor cells (5/8).

Her2: Weak incomplete membranous staining of > 10% tumor cells (Score 1+)

Ki67: Positive nuclear staining of 40% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast mass , tru-cut biopsy:

Invasive Ductal Carcinoma, (NST) Grade II .
(ER 8/8, PR 5/8, Her2 Score 1+, Ki67 40%).

Signature:

Dr.Nermine Nabil.M.D

Dr.Mona.Mohamed.M.D

Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Patient ID: 86939	Patient Name English: Zainab Ibrahim Mohamed
Age: ٥٧ سنة, ١ شهر	2025/08/25 11:50:17 AM :Report Date

Women's Health Outreach Program

Name: Zelnab Ibrahim mohmaed

Date: 25-8-2025

Bilateral full field Digital Mammography

Clinical summary: right? Lump

Technique

Medio-lateral oblique and CC views & High resolution ultrasound

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- LOQ focal asymmetrical area, target us showed altered parenchyma seen at 6:7 o'clock (zone b), showing irregular hypoechoic solid lesion within it, about 5mm from the overlying skin, measuring 1.7x2.3cm (corresponding to area of concern).
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Few indeterminate axillary LNs (level I), yet with preserved hilum, one of them rounded in shape.

Left breast

- Scattered fibroglandular densities (ACR B)
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of microcalcifications.
- Scattered benign calcifications
- Ultrasound demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

Right breast (BIRADS 4):

- LOQ suspicious solid lesion(biopsy was taken at the same setting) , with ipsilateral few indeterminate axillary LNs (level I)

Left breast (BI-RADS 2):

- Scattered benign calcifications

Recommendations

- CESM

Best regards
Dr. Sara Gamal, MSc

Patient Name: Zainab Ibrahim Mohamed Al Shamma'	Date : 02/10/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 57 Year(s)
Medical ID: 2581/2025	Pat. ID: 121871

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

**** A known case of right breast cancer(IDC)**

I Chest: -

- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes .
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged in size with homogenous fatty CT texture with segment IV focal fat sparing area . No focal lesions or contour irregularities.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys (apart frm left renal small cortical cyst 1 x1 cm)with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

III The scanned skeleton:

- No worrisome lytic or sclerotic bony lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

Opinion:

No hepatic , pulmonary or bony metastatic deposits

Dr. Reham Khedr, MD

مستشفى
السيدي
البيضاوي
بمصر

9-27



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الهيئة العامة
لصحة
المرأة

09/27/2026

MDT FORM

Name:	Zainab Ibrahim Mohamed Al Shamra	MRN:	4167
Age:	58 Y	ID:	26807042100586
Menopausal Site	POST MENOPASUAL	Phone:*	01117156515
NRS SCORE:		Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	FREE
Gender		Reason Of MDT:	
CO Morbidity:	HTN	POST OP	
Surgical History:*	FREE	ECOG Performance Status	0 1 2 3 4

Clinical Data:

R L



T N M

BX:	IDC G2
ER:	8/8
PR:	5/8
HER2:	0
KI67:	40%

History:
POST NACT
RT BCS+SLNB
FREE MARGINS 1/6 LN WITHOUT EXTRANODAL EXTENSION

Sonomammography:
postm rt breast cancer ct2 n1 mo idc 2 er8/8 pr5/8 her2-ve ki 40% pt rec
4 ac 12 taxol last 3/5/2026 clips inserted sm 7/6/2026 almost complete
radiological response

Biomarker/Molecular

Mets Workup:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan
port
(AI 7 YS) +/- CDK 4/6 (NGO)

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Right Side								
Left Side								

Clinical Staging:

Pathological Staging:

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
د محمد كوازي	د محمد كوازي	د فرات رسلان	

Signature